

1. Introducción y relevancia clínica

El **papiledema** se define como el **edema bilateral del disco óptico secundario al aumento de la presión intracraneal (PIC)**.

No es una enfermedad en sí misma, sino un **signo clínico de alarma** que refleja la presencia de una **lesión intracraneal, trastorno del flujo del LCR o hipertensión intracraneal idiopática (HII)**.

Su **relevancia clínica** radica en que:

- Es un **signo de hipertensión intracraneal potencialmente letal**.
- Requiere **evaluación neurológica y neuroimagen inmediata**.
- Puede causar **pérdida visual irreversible** si no se trata.
- Es un diagnóstico **clave en EUNACOM**: se pregunta su fisiopatología, hallazgos fundoscópicos y diagnóstico diferencial (neuritis óptica, pseudopapiledema).

En la práctica clínica chilena, el papiledema debe sospecharse en todo paciente con **cefalea progresiva, vómitos en proyectil o visión borrosa**, especialmente si existen signos focales o alteraciones de conciencia.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía y comunicación intracraneal

El nervio óptico es una **extensión del sistema nervioso central (SNC)**, rodeado por las mismas meninges (duramadre, aracnoides y piamadre) y bañado por **líquido cefalorraquídeo (LCR)** en su vaina subaracnoidea.

Cuando la **presión del LCR aumenta**, se transmite a lo largo de la vaina hasta la **cabeza del nervio óptico**, generando:

- **Compresión axoplásmica** → edema axonal.
- **Congestión venosa local** → extravasación de fluido.

- Engrosamiento y borramiento del borde papilar.
-

2.2 Mecanismo fisiopatológico

1. **Aumento de la presión intracraneal (PIC)** → transmisión del gradiente de presión hacia la vaina del nervio óptico.
 2. Se **obstruye el flujo axoplásmico anterógrado** en el nervio a nivel de la lámina cribosa.
 3. Esto genera **acumulación de material intracelular y edema axonal**.
 4. Secundariamente ocurre **congestión capilar y extravasación de líquido**.
 5. Si el proceso persiste → **atrofia óptica secundaria**.
-

2.3 Principales causas

Grupo etiológico	Ejemplos
Lesiones expansivas intracraneales	Tumores cerebrales, abscesos, hematomas sub/epidurales, metastásis.
Trastornos del LCR	Hidrocefalia, meningitis, encefalitis, trombosis de senos venosos, hipertensión intracraneal idiopática.
Causas metabólicas / tóxicas	Hipervitaminosis A, tetraciclinas, isotretinoína, esteroides, fallo renal.
Hipertensión intracraneal idiopática (HII)	Mujeres jóvenes con sobrepeso, sin lesión estructural evidente.

Causas raras	Malformaciones arteriovenosas, pseudotumor cerebri secundario a fármacos.
--------------	---

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas clínicos generales

El papiledema **no produce síntomas visuales en etapas iniciales**, pero se asocia a **síntomas de hipertensión intracraneal (HIC)**:

- **Cefalea** (predominantemente matinal, que empeora con maniobras de Valsalva).
 - **Náuseas y vómitos en proyectil.**
 - **Diplopía horizontal** (por paresia del VI par craneal).
 - **Fotopsias o visión borrosa transitoria (“flashes” o “oscurecimientos fugaces”).**
 - **Alteración de conciencia o convulsiones** (según causa).
-

3.2 Signos oftalmoscópicos (fondo de ojo)

Evolución en etapas:

Etapas	Hallazgos característicos	Comentario
I. Inicial (incipiente)	Borramiento del borde nasal del disco, ligera hiperemia.	Sin hemorragias aún.
II. Establecido (moderado)	Borramiento completo del borde, elevación del disco, vasos dilatados y tortuosos, hemorragias peripapilares, exudados blandos.	Más frecuente en la consulta.

III. Avanzado	Elevación marcada (>3D), hemorragias en llama y exudados duros en “estrella macular”.	Pérdida visual comienza.
IV. Crónico / atrófico	Disco óptico pálido, bordes nítidos nuevamente por atrofia, pérdida visual permanente.	Secuela irreversible.

□ El hallazgo característico es la **bilateralidad simétrica**, salvo en lesiones localizadas (tumores del quiasma, asimétricas).

3.3 Diagnóstico diferencial

Entidad	Diferencias clave
Neuritis óptica	Dolor ocular con movimientos, pérdida visual rápida y unilateral, fondo con edema leve o normal.
Pseudopapiledema (drusas del NO)	Bordes elevados pero brillantes, sin hemorragias ni exudados, visión normal, OCT o autofluorescencia positiva.
Neuropatía óptica isquémica anterior (NOIA)	Mayor de 50 años, sin signos de HIC, fondo con edema pálido, visión severamente afectada.
Papiloflebitis	Jóvenes, unilateral, hemorragias más marcadas, sin HIC.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 En atención primaria (APS)

Ante sospecha (cefalea, vómitos, visión borrosa, papila elevada):

- **Fondo de ojo directo:**

- Borramiento de bordes, elevación del disco, hemorragias peripapilares.
- **Evaluar signos neurológicos:** pares craneales, conciencia, fuerza, reflejos.
- **Medir PA:** descartar hipertensión maligna.
- **Derivar urgente a urgencia hospitalaria / neurología.**

□ **Nunca realizar punción lumbar sin neuroimagen previa.**

4.2 En hospital o consulta especializada

Examen	Propósito
Neuroimagen (TAC o RM cerebral con contraste)	Excluir masa, hidrocefalia o trombosis de senos venosos.
Angio-RM / Venografía MR	Diagnóstico de trombosis de seno sagital.
Punción lumbar (después de imagen normal)	Medir presión de apertura (>25 cm H ₂ O en decúbito lateral).
OCT (tomografía de coherencia óptica)	Cuantifica edema de fibras nerviosas y seguimiento.
Campimetría visual	Detecta escotomas agrandados o contracción concéntrica del campo.
Laboratorios dirigidos	Buscar causas metabólicas (función renal, B12, tóxicos, fármacos).

4.3 Criterios diagnósticos (AAO / MINSAL adaptado)

Papiledema confirmado si:

1. Fondo de ojo con **edema bilateral de disco óptico** con vasos dilatados y hemorragias peripapilares.
 2. Evidencia de **presión intracraneal aumentada** (clínica o medición directa).
 3. **Neuroimagen sin masa ocupante (en HII)** o con lesión causal identificada.
 4. **Campos visuales alterados** (escotomas, aumento mancha ciega).
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIOF / AAO)

El manejo depende de la **causa subyacente del aumento de PIC**.

5.1 Conducta general inicial

1. **Derivación urgente a neurología o neurocirugía.**
 2. **Neuroimagen inmediata (TAC o RM cerebral).**
 3. **Suspender medicamentos asociados:** tetraciclinas, vitamina A, isotretinoína, esteroides.
 4. **Evitar punción lumbar hasta descartar masa.**
-

5.2 Tratamiento según causa

Etiología	Manejo principal
Tumor / masa intracraneal	Neurocirugía, reducción de masa, corticoides (dexametasona 4 mg EV/6h).
Hemorragia / absceso / hidrocefalia	Manejo quirúrgico o drenaje.

Trombosis de senos venosos	Anticoagulación + tratamiento de causa (infección, deshidratación, puerperio).
Hipertensión intracraneal idiopática (HII)	Pérdida de peso + acetazolamida 500–1000 mg/día (disminuye producción de LCR). Si falla → furosemida o topiramato.
Fármacos / tóxicos	Suspender agente causal.
Hipervitaminosis A / tetraciclinas	Suspensión inmediata + acetazolamida.

5.3 Medidas de emergencia

- **Corticoides EV** si edema papilar severo por masa o inflamación.
 - **Manejo de PIC:**
 - Elevación cabecera 30°.
 - Restricción hídrica moderada.
 - Manitol 20% EV (1 g/kg) en emergencia con compromiso visual o neurológico.
 - **Neurocirugía** si hay herniación o deterioro rápido.
-

5.4 Manejo oftalmológico

- **OCT y campimetría seriada:** seguimiento del edema y daño.
 - **Cirugía descompresiva de vaina del NO** (raro, en HII con pérdida visual progresiva).
 - **Derivar a nutrición en obesidad.**
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Mecanismo	Resultado
Atrofia óptica secundaria	Isquemia y degeneración axonal.	Pérdida visual permanente.
Pérdida visual progresiva	Por daño crónico del NO (HII no tratada).	Ceguera parcial o total.
Recidiva (HII)	Falta de adherencia a pérdida de peso o fármacos.	Recaídas con nuevos episodios de edema.
Hernia cerebral	En casos de aumento súbito de PIC sin tratamiento.	Muerte.

Pronóstico:

- Depende de la causa y rapidez del diagnóstico.
- En HII tratada, 90% mantiene visión normal.
- En tumores o trombosis, pronóstico reservado según lesión.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Papiledema = edema bilateral de papila por aumento de PIC.**
2. **Nunca hacer punción lumbar sin neuroimagen previa.**
3. **HII:** mujer joven con sobrepeso, cefalea matinal, visión borrosa transitoria, papiledema.
4. **Edema de papila + masa = emergencia neurológica.**

5. **Acetazolamida** es el tratamiento médico de elección en HII.
 6. El papiledema inicial **no disminuye agudeza visual** hasta fases avanzadas.
 7. **OCT y campos visuales** son esenciales para seguimiento.
-

Errores comunes

- Confundir papiledema con **neuritis óptica o pseudopapiledema**.
 - No derivar de urgencia ante cefalea + papila elevada.
 - Realizar **punción lumbar antes de descartar masa**.
 - Indicar esteroides sin causa identificada.
 - No sospechar HII en mujer obesa con cefalea crónica.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **papiledema** es el **edema bilateral del disco óptico por aumento de presión intracraneal**, no una enfermedad en sí.
2. Su causa más frecuente es la **hipertensión intracraneal idiopática (HII)**, pero debe **descartarse masa o trombosis venosa**.
3. Los síntomas cardinales son **cefalea matinal, vómitos, visión borrosa transitoria** y ocasional diplopía.
4. El diagnóstico se basa en **fondo de ojo bilateral con bordes borrados + neuroimagen**.
5. **Nunca se realiza punción lumbar sin imagen cerebral previa**.
6. El tratamiento depende de la causa, destacando **acetazolamida y pérdida de peso** en HII.
7. El pronóstico visual es **excelente si se maneja precozmente**; la **atrofia óptica** es la complicación final más temida.